

22 - 10- CAT devant un érythème noueux - Pr. Amal

(0:04 - 0:53)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé « La conduite à tenir devant un érythème noueux ». Les objectifs de ce cours sont de diagnostiquer un érythème noueux, mener une enquête étiologique, en effet l'érythème noueux est un syndrome avec la possibilité de plusieurs étiologies, argumenter les principales hypothèses diagnostiques, reconnaître le principe de traitement de l'érythème noueux. La lésion élémentaire dans l'érythème noueux, ce sont des noueures ou nodosités. Ce sont des élevures fermes, consistantes, érythémateuses ou de coloration normale.

(0:55 - 1:24)

Ces lésions traduisent un infracellulaire hypodermique surtout, le derme parfois, mais surtout hypodermique septale. Un rappel histologique de la peau, vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc ici, l'infiltrat, les noueures, c'est des infiltrats hypodermiques et dans l'hypoderme vous avez les lobules graisseuses et entre les lobules graisseuses vous avez du septant.

(1:24 - 1:52)

Dans le cadre de l'érythème noueux, l'infiltrat touche le septant, c'est un infiltrat septal, il n'y a pas d'atteinte des lobules graisseuses. C'est un infiltrat inflammatoire non spécifique, sans vascularite. Voici les lésions cliniques, donc vous voyez une légère surélévation, mais c'est des lésions infiltrées.

(1:52 - 2:19)

Il faut faire attention, ce ne sont pas des macules érythémateuses ici, ce sont des noueures et on connaît l'infiltration de ces lésions par la peau. Vous voyez ici, on essaie de limiter la lésion, donc ce sont des lésions, voici les lésions d'érythème noueux, des noueures, ce sont des lésions qui infiltrent l'hypoderme. L'érythème noueux est une éruption d'hermo-hypodermique aiguë non spécifique.

(2:21 - 2:52)

L'intérêt de ce syndrome, c'est qu'il peut être en rapport avec de nombreuses causes obligeant donc le médecin à rechercher l'étiologie afin de proposer un traitement adéquat. Parfois, on ne trouve pas d'étiologie, on parle d'érythème noueux idiopathique. Sur le plan épidémiologique, les femmes sont les plus souvent atteintes que les hommes avec un sexe ratio de 3 à 7 femmes pour un homme, ça touche le sujet jeune entre 20 et 40 ans.

(2:53 - 3:59)

Il existe un facteur saisonnier, l'érythème survient le plus souvent en hiver. Donc, il y a trois phases dans l'érythème noueux, donc une phase prodromique non spécifique qui précède l'apparition des lésions cutanées, dure de 3 à 6 jours, marquée par une fièvre, des douleurs articulaires, des arthralgies, parfois des douleurs abdominales, avec parfois donc une infection rhinopharyngée, une enterration légère de l'état général. Et puis, vous avez la phase d'état qui s'installe rapidement en 1 à 2 jours, donc vous avez les lésions cutanées qui apparaissent, donc les nourrices apparaissent aux phases d'extension des jambes et des genoux, parfois des couilles et des avant-bras, donc le nombre est variable, 3 à 6 éléments parfois plus, bilatérales mais non symétriques et spontanément douloureuses.

(4:01 - 4:29)

Le syndrome général avec la fièvre et les arthralgies de la phase prodromique persiste, parfois s'accroît. Les lésions sont de quelques centimètres de diamètre, chaudes, fermes à la palpation, douloureuses, mobiles par rapport au plan profond. La douleur des lésions est exacerbée par l'orthostatisme et on peut trouver un oedème d'éclive au niveau des chevilles.

(4:30 - 4:55)

Voici donc les lésions. Les nourrices sont en général bilatérales mais non symétriques, le nombre des lésions est variable. Elles sont irritantes, douloureuses, spontanées à la palpation, c'est douleur aggravée par la position, par l'orthostatisme, associée à des arthralgies, parfois douleur abdominale, une fièvre.

(4:57 - 7:34)

Et puis vous avez la troisième phase, donc la phase régressive, c'est une évolution régressive, elle est spontanée, accélérée par le repos qui fait partie du traitement, qui fait partie de la prise en charge du patient. Donc chaque nourrice évolue en une dizaine de jours en prenant des aspects quantitatifs bleus et jaunettes, donc les couleurs de la nourriture, la biligénie, et il y a disparition intégrale des lésions, sans séquelles. L'irritation nouvelle régresse sans laisser de cicatrices, sans laisser d'ulcérations, sans laisser de nécroses.

Donc un irritum nouveau ne comporte jamais de nécroses, d'ulcérations ou de cicatrices. Si vous voyez ces éléments-là, ce n'est pas un irritum nouveau, c'est peut-être une vascularite et c'est une indication à la biopsie. Donc l'irritum nouveau évolue souvent en plusieurs poussées, favorisées par l'orthostatisme, pouvant s'échelonner sur quatre à huit semaines.

La succession des poussées confère à l'éruption un aspect polymorphe avec des nourrices d'âges différents comportant les diverses teintes de la biligénie. Donc on a dit qu'il y a des signes associés à l'éruption, donc la fièvre, les arthralgies. On peut trouver des adénopathies périphériques et parfois une atteinte oculaire à type d'uvéite, conjunctivite ou épisclérite.

La présence de signes digestifs fera chercher une colite inflammatoire ou une myerséniose. Donc sur le plan biologique, on trouve un syndrome inflammatoire mais qui n'est pas spécifique, donc une vitesse de sédimentation accélérée, une hyperlococytose avec une polynucléose neutrophile et une hyperfébrinémie. La biopsie, on ne fait pas de biopsie.

Donc si on fait une biopsie, on va trouver une inflammation neutrophilique dans un infiltré inflammatoire fait par des polynucléaires neutrophiles. Au niveau de septômes interlobulaires, donc au niveau de septômes sans vascularites et sans donc lésion de panécrites, sans lésion des lobules graisseuses. La biopsie, c'est lorsque, donc en cas de doute, on va voir l'indication de biopsie, c'est lorsqu'on suspecte d'autres pathologies.

(7:36 - 13:43)

Le diagnostic différentiel peut se poser au stade de début avec des réactions à l'impicure d'insectes devant cet érythème douloureux. L'érysipèle, mais en général l'érysipèle est un placard irréprimable unilatéral. Les flérites superficielles, ils siègent sur les trajets veineux, tels les faces latérales des jambes.

Les flérites nodulaires, ils se voient surtout au cours de la maladie de Bessette. Ils siègent sur les trajets veineux. Ils n'ont pas cette évolution quantiforme de l'érythème douloureux.

Et là, en cas de doute, on fait la biopsie qui va montrer la prédominance d'une vascularite avec atteinte veineuse. Donc, dans le cadre des hypodermes nodulaires, vous avez l'érythème douloureux. C'est une hypoderme nodulaire aiguë avec un infiltrat septal.

Donc, c'est une hypoderme septale sans vascularite. S'il y a une vascularite, vous avez d'autres pathologies qui peuvent donner un tableau de vascularite nécrosante. Vous avez la périarthrite noueuse, la maladie de Wegener, la maladie de Church-Strauss, l'érythème indirect de Vazin.

Et là, c'est les étiologies des hypodermes globulaires, mais ce sont des lésions en général chroniques. Vous voyez plusieurs lésions. Ça, ce sont des diagnostics différentiels, mais rappelez-vous, l'érythème douloureux, c'est une infection aiguë.

Et là, ce sont des lésions des lésions des hypodermes chroniques. Et c'est là l'indication de la biopsie cutanée. Donc, on a dit que l'érythème douloureux, il n'évolue pas vers une ulcération.

Donc ici, vous voyez, lorsque vous avez ces lésions comme ça, c'est une indication de la biopsie. Et là, on trouve soit des vascularites granulomateuses, soit des panécrites d'origine systémique, ou donc d'autres étiologies. Mais l'érythème douloureux ne donne pas d'ulcération ni de nécrose.

Donc, les lésions, les graisses sont laissées de cicatrices. Maintenant, pour les étiologies de l'érythème douloureux, donc il y en a plusieurs. L'étiologie, vous voyez, il y a les infections bactériennes.

Donc, ce qui est important dans notre contexte, c'est surtout la tuberculose. L'érythème douloureux post-streptococcique, qui reste l'étiologie la plus fréquente. Vous avez la yersiniose.

Vous avez également donc les autres infections virales, parasitaires, les infections générales. Vous avez la maladie de V7, les entéropathies, donc Crohn et RCH, la sarcoïdose. Et puis, vous avez quelques infections malignes, c'est possible, la maladie de Toskine, le C1000 et l'infarct, des cancers solides.

Vous avez les toxidermies médicamenteuses, donc les antibiotiques, surtout donc les sulfamides, les oestrogènes. Donc, vous voyez que l'érythème douloureux, donc il y en a plusieurs étiologies. Donc, pour récapituler, donc les étiologies les plus fréquentes, vous avez les formes apparemment idiopathiques.

Ça reste l'étiologie la plus fréquente, entre parenthèses d'étiologie, parce qu'on ne trouve pas d'étiologie, donc c'est des formes idiopathiques. Dans certaines séries, ça arrive jusqu'à 50 %. La sarcoïdose, dans le cadre du syndrome de Lofgren. Dans notre contexte, la tuberculose, il faut y penser, c'est le premier diagnostic, il faut penser à la tuberculose.

Mais l'étiologie la plus fréquente, c'est l'érythème douloureux post-streptococcique. Vous avez le streptococque et puis vous avez les autres infections. Vous avez les maladies, donc les entéropathies inflammatoires, RCH-Coron, les maladies de Bessette, les médicaments, les maladies, les infections malignes, la grossesse.

Tout ceci, cette liste des étiologies, nous oblige à faire une enquête étiologique. Donc il faut chercher sur le plan clinique des éléments qui orientent vers une étiologie, donc antécédents d'infections streptococciques, antécédents de maladies digestives, notion de prise médicamenteuse, les signes digestifs, etc. Donc les éléments d'orientation clinique.

Sur le plan biologique, on fait un bilan minimum en phase aiguë. Donc on fait une numération formule sanguine, une VES, dosage de transaminase, séro-diagnostic pré-streptococcique, les ASLO, les examens bactériologiques du front de gorge, donc à la recherche du streptococque, une radiographie du thorax à la recherche des lésions qui orientent soit vers une primo-infection tuberculose ou vers une sarcoïdose, des adénopathies médicinales, des tests tuberculiniques qui orientent vers une primo-infection tuberculose ou vers la sarcoïdose. Donc dans la sarcoïdose, il y a une énergie tuberculinique, donc les tests sont négatifs.

Et on peut faire également une coproculture lorsqu'il y a des signes digestifs pour chercher une infection ayersienne. Et on complètera ultérieurement en fonction des résultats de ce premier bilan. Donc si vous avez par exemple une cytolysé, à ce moment-là, on complète par les sérologies de l'hépatite, PSC.

Donc la rentabilité du bilan n'est pas excellente parce que dans les séries publiées, on a dit que parfois, on ne trouve pas de cause à cet érythème nouveau. Donc dans les séries, c'est entre

15% à 55%. On ne trouve pas de cause, on parle d'érythème nouveau édiopathique.

(13:45 - 17:19)

Donc on va voir les étiologies les plus fréquentes. Vous avez l'érythème nouveau post-reptococcique. Donc il y a généralement une précession d'une angine trois semaines avant l'apparition de l'érythème nouveau.

Et classiquement, dans cette situation, l'érythème nouveau serait très inflammatoire. Donc les lésions sont très rouges, très douloureuses, récidiveraient plus souvent et pourraient comporter une phase desquamative. Donc dans le streptococci, il peut y avoir une desquamation.

Donc le plus souvent, une desquamation scarlatiniforme. Leur traitement par les antibiotiques, le piliciline ou le macrolide, est impératif pour raccourcir l'évolution et pallier le risque des complications viscérales de toute infection streptococcique et notamment le GMA. La tuberculose, c'est la première cause à évoquer dans notre contexte.

Ce n'est pas la première étiologie, mais c'est la première cause à évoquer dans notre contexte. On reste un pays d'endémies tuberculeuses. Donc l'érythème nouveau fait classiquement partie du tableau de primo-infection tuberculeuse.

Donc là, la présence d'autres signes et de diagnostics comme la fièvre, les signes non-psychos, l'altération de l'état général, la notion de comptage, le virage récent des tests tuberculiques, la présence d'un chancre d'inoculation avec adénopathie médiastinale à la radio du poumon, l'existence d'une keratoconjunctivite flexinulaire. Donc tout ça, ce sont des éléments qui orientent vers la primo-infection. La hiércinose.

Donc il faut penser à la hiércinose devant des signes digestifs, des douleurs abdominales ou syndrome pseudo-appendiculaire chez l'enfant. Parfois, ça donne des douleurs de la fosse électroïde, c'est des malades opérés pour un appendicite. Donc l'anapathie, l'examen histologique, la pièce opératoire est normale.

Donc là, il faut penser à la hiércinose. Des signes contemporains tels qu'une diarrhée. Deux bacilles sont responsables.

Vous avez la hiércinia enterocolitica chez l'adulte et la hiércinia pseudo-tuberculosis chez l'enfant et l'adolescent. Le diagnostic peut être confirmé par les co-procultures et les séro-diagnostics. L'évolution est habituellement courte, en général trois semaines.

Dans la lèpre, l'érythème louveux se trouve surtout dans la forme lépromoteuse multivasculaire. Donc après installation générale du traînement et lorsque le malade commence à développer une immunité. Il ne s'agit pas proprement de dire d'une hypodermie, mais d'une vascularité à complexe humain provoquée par une infection, un stress ou des modifications thérapeutiques.

Donc c'est après l'installation du traînement. Il peut s'y associer des œdèmes, une érythème aiguë, une iridocyclite, une polyarthrite ou une globérulonéphrite. Les autres maladies infectieuses, il y a chlamydia, mycoplasme, réquisite, rubeola, histoplasma, la mononucléose infectieuse, l'hépatite B, la rougeole, la grippe, polydysoptoxoplasmosis, trépanosomiase et cette liste n'est pas exhaustive.

(17:21 - 19:59)

La sarcoïdose, il intervient dans 10 à 20% des cas. Il chose surtout la femme jeune. L'association d'iridèmes nouveaux avec alergie et adénopathie médiastinale réalise le syndrome de Löfgren.

Le diagnostic nécessite une radiographie ou un scanner thoracique à la recherche des adénopathies hilaires bilatérales caractéristiques. L'intradermoréaction à la tuberculine plus souvent négative, il prend une valeur d'autant plus grande qu'on a une preuve de sa positivité antérieure. Dans la sarcoïdose, il y a aussi une élévation, on peut avoir une élévation d'enzymes de conversion d'enzymes et également une hypercalcémie, une lymphopénie et il y a d'autres signes, donc d'autres manifestations cutanées ou extracutanées de la sarcoïdose qu'il faut chercher.

Parmi les étiologies de l'iridème nouveau, on cite également les entéropathies chroniques, la rectocolite ulcéreuse et la maladie de Crohn. L'iridème nouveau survient pendant la première année d'évolution. C'est parmi les manifestations extra-digestives de ces colites inflammatoires.

Vous avez l'iridème magnum crénosum, vous avez les aftes. Donc, l'existence des manifestations digestives au cours d'un iridème nouveau doit amener à chercher systématiquement une maladie inflammatoire chronique, Crohn et RCH. Et bien sûr, il faut éliminer une infection àirschman qui est plus fréquente.

Plus rarement, l'iridème nouveau peut évoluer indépendamment des signes digestifs et même les précédents. Cependant, en l'absence de signes d'appel, l'exploration intestinale systématique n'est pas recommandée. On ne fait pas systématiquement une colonoscopie devant un iridème nouveau, sauf s'il y a des signes d'appel digestif.

Les autres maladies systémiques, vous avez la maladie de Behçet, surtout. Vous avez la polyarthrite humanoïde, le lupus, la maladie de Takahashi, la maladie de Horton. Mais ici, le contexte clinique permet souvent d'orienter le diagnostic étiologique.

Donc, l'origine médicamenteuse de l'iridème nouveau est difficile à confirmer. Ça reste un diagnostic d'élimination. Donc, il faut penser aux autres étiologies avant de retenir le diagnostic de toxidermie médicamenteuse.

(19:59 - 20:35)

Et à ce moment-là, on arrête les médicaments pour voir l'évolution. Donc, les médicaments incriminés, vous avez l'aspirine, les anti-inflammatoires de façon globale, les pilules oestro-progestatifs et les sulfamides. Exceptionnellement, l'iridème nouveau peut être dû ou peut parfois révéler certaines infections malignes, la maladie d'Hodgkin, ou les lympho-malignants Hodgkinien à le sémi-éguméloïde, le semi-lymphoïde chronique et certains carcinomes solides.

(20:38 - 22:26)

Donc, pour le traitement, quelle que soit l'éthiologie, il y a un traitement symptomatique. Donc, le repos, c'est très important. Donc, ça permet d'améliorer la douleur, de soulager le malade, de soulager la douleur et de raccourcir la durée de l'évolution des lésions.

Les onalgiques, par incitamol ou des anti-inflammatoires non séruvidiens, parfois on donne la colchicine ou la dizulone, surtout dans les formes récidivantes, où on n'arrive pas à trouver une éthiologie. Le recours à une corticothérapie générale à titre symptomatique est exceptionnellement nécessaire. À ce moment-là, on instaure une corticothérapie de courte durée.

Dans les formes récidivantes, qui sont souvent de causes streptococciques, l'antibio-prophylaxis par pénicilline peut être bénéfique. Donc, on peut prescrire de la pénicilline, donc si le malade développe des érythèmes nouveaux post-streptococciques de façon répétitive. Et bien sûr, à côté de ce traitement systémique, il faut donc donner un traitement éthiologique, et là, c'est en fonction de l'éthiologie.

S'il s'agit d'une primo-infection tuberculeuse, il faut associer, donc il faut donner des antivaccinaux et ainsi de suite, donc en fonction de l'éthiologie sous-jacente. Donc, en guise de conclusion, l'érythème nouveau est une infection de diagnostic clinique. Ses éthiologies sont nombreuses, dominées par la tuberculose et l'infection streptococcique.

Il faut cependant s'acharner à retrouver l'éthiologie dans les cas récidivants afin de proposer un traitement adéquat.